

Atualizações - Imunizações em Pediatria

Introdução:

O tema das **Imunizações** representa um desafio na jornada de estudos para a residência médica. Todos os anos, há atualizações do **Programa Nacional de Imunizações (PNI)** do Brasil. Dessa forma, o aluno deve estar atento ao resolver as questões de provas antigas, já que muitos gabaritos podem estar desatualizados frente às recomendações mais recentes.

Este documento reúne as alterações no calendário vacinal do PNI desde **2020 até 2025**, organizadas por vacina, permitindo ao aluno comparar o “antes x depois” das principais mudanças.

Calendário de Vacinação PNI - 2025:

Ao nascer	BCG + Hepatite B
2 meses	Penta + Rotavírus + VIP + Pneumo10V
3 meses	MeningoC
4 meses	Penta + Rotavírus + VIP + Pneumo10V
5 meses	MeningoC
6 meses	Penta + VIP + COVID-19 + Influenza

7 meses	COVID-19 + Influenza
9 meses	Febre amarela + COVID-19***
12 meses	SCR + MeningoACWY + Pneumo10V
15 meses	Hepatite A + DTP + Tetraviral + VIP
4 anos	Varicela + Febre amarela + DTP
9 - 14 anos	HPV (dose única)
11 - 14 anos	MeningoACWY

*** A depender do imunizante utilizado inicialmente, algumas crianças podem ter que receber esta dose para completar o esquema - não são todos que devem recebê-la (vide mais informações na tabela do subitem **COVID-19**)

Mudanças no Calendário do PNI (2020 - 2025):

HPV (Papilomavírus Humano):

→ Data da mudança: a partir de abril/2024

O Ministério da Saúde reorganizou o esquema de HPV no calendário, simplificando para **dose única**, entre 9 e 14 anos, e ampliando estratégias de resgate para até 19 anos.

Grupos de risco e situações especiais:

→ 3 doses (intervalo entre doses: 0, 2 e 6 meses):

- Pessoas vivendo com HIV/Aids
- Transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea
- Pacientes oncológicos (em tratamento de câncer)
- Vítimas de violência sexual entre 15-45 anos

- Usuários de PrEP (profilaxia pré-exposição ao HIV), de 15-45 anos, que não tenham tomado a vacina HPV ou estejam com esquema incompleto (de acordo com esquema preconizado para idade ou situação especial)
- Portadores de papilomatose respiratória recorrente a partir de 2 anos de idade

→ 2 doses (intervalo entre doses: 0 e 6 meses):

- Vítimas de violência sexual entre 9-14 anos

ASPECTO	COMO ERA	COMO FICOU
Esquema básico em PNI	Duas doses para adolescentes (meninos e meninas), com intervalo entre doses conforme o manual técnico vigente até então	Dose única
Faixa etária alvo	Meninas: 9-14 anos Meninos: 11-14 anos	9-14 anos para ambos os sexos
Resgate de doses atrasadas	Realizado por campanhas específicas, mas não sistematizado no calendário	Busca ativa e vacinação de resgate até 19 anos para quem não tomou na idade recomendada
Exceções / Grupos especiais	Esquema de 2 ou 3 doses a depender da situação clínica específica	Mantido esquema de 2-3 doses a depender da situação clínica específica

COVID-19:

- Início da vacinação no Brasil: 17/01/2021 (campanha emergencial)
- Incorporação ao PNI: 01/01/2024

A vacina contra o SARS-CoV-2 foi inicialmente aplicada em caráter emergencial, durante a pandemia. A partir de 2024, a vacinação contra COVID-19 foi formalmente incorporada ao calendário de rotina do PNI com recomendações para diferentes grupos etários.

GRUPO	COMO ERA	COMO FICOU
Crianças de 6 meses a < 5 anos	Campanhas específicas com esquemas variáveis de 2 doses + reforços	• Pelo menos 2 doses • Alguns imunizantes específicos (como Pfizer - Comirnaty) preconizam 3 doses • O número de doses e o intervalo entre elas dependerá da bula técnica do imunizante utilizado • Priorizar o uso do mesmo imunizante do início ao fim do esquema
Idosos (a partir de 60 anos)	Reforços conforme campanhas emergenciais	• Reforços regulares a cada 4-6 meses • Baseado em

		avaliação de risco
Gestantes	Vacinação recomendada nas campanhas, com intervalos emergenciais	1 dose a cada gestação
Imunocomprometidos (a partir de 6 meses)	Esquemas emergenciais variáveis com reforços adicionais	• Esquema primário: 3 doses com intervalo de 4 semanas entre a 1ª e a 2ª dose e de 8 semanas entre a 2ª e a 3ª doses • Vacinação periódica semestral (pelo menos 1 dose a cada 6 meses)
Grupos especiais *	Esquemas emergenciais variáveis com reforços adicionais	• 1 dose anual • Avaliar necessidade de reforços periódicos conforme cada grupo
População geral (5-59 anos)	Variação conforme campanhas de reforço emergenciais	Dose única (as doses recebidas nas campanhas emergenciais já valem)

* **Grupos especiais:** pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, puérperas não vacinadas durante a gestação, trabalhadores de saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de

liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua, trabalhadores dos Correios

Influenza:

→ Data de inclusão completa no calendário rotineiro: a partir de 2025

A grande mudança de 2025 foi a ampliação da oferta contínua (rotineira) da vacina influenza, não mais restrita apenas às campanhas sazonais

ASPECTO	COMO ERA	COMO FICOU
Indicação principal	Campanhas sazonais anuais (geralmente outono/inverno) para grupos específicos (crianças, idosos, gestantes, etc.)	Vacina de rotina ao longo do ano para crianças (≥ 6 meses a < 6 anos), idosos, gestantes e outros grupos ampliados
Crianças menores de 9 anos	2 doses para primovacinados (campanhas)	1ª e 2ª doses para novos vacinados < 9 anos, com intervalo mínimo de 30 dias
Restante da população	Prioritário em campanhas para grupos especiais, não em rotina	Inclusão no calendário para gestantes, puérperas, comorbidades, indígenas, profissionais de saúde, professores, segurança pública, privados de liberdade e outros grupos prioritários adicionais

Poliomielite:

→ Data da mudança: 2025

Houve substituição das doses de VOP (vacina oral) por VIP (vacina inativada) na rotina do calendário nacional, promovendo uniformidade e segurança. Além disso, antes a criança recebia dois reforços de VOP (15 meses e 4 anos), que foram substituídos por dose única de reforço com VIP aos 15 meses.

ASPECTO	COMO ERA	COMO FICOU
Esquema básico	1ª dose aos 2 meses 2ª dose aos 4 meses 3ª dose aos 6 meses	1ª dose aos 2 meses 2ª dose aos 4 meses 3ª dose aos 6 meses
Reforço	VOP aos 15 meses e 4 anos	VIP (vacina inativada poliomielite) como reforço único aos 15 meses, sem VOP no calendário de rotina

Rotavírus:

→ Data da alteração: 2025

O limite de idade para doses da vacina contra rotavírus foi ampliado, aumentando oportunidades de proteção para crianças que perderam doses anteriormente.

ASPECTO	COMO ERA	COMO FICOU
Faixa etária de administração	1ª dose até 3 meses e 15 dias 2ª dose até 7 meses e 29 dias	1ª dose até 11 meses e 29 dias 2ª dose até 23 meses e 29 dias

Meningocócica (C e ACWY):

→ Data da alteração: 2025

O reforço da vacina meningocócica aos 12 meses passou a usar a fórmula ACWY, que protege contra mais sorogrupos (A, C, W e Y).

ASPECTO	COMO ERA	COMO FICOU
Reforço aos 12 meses	Meningocócica C	Meningocócica ACWY
Adolescentes	ACWY aplicada em calendários específicos	Dose única ou reforço com ACWY

Sarampo:

→ Data da alteração: 2025

Devido ao aumento da incidência de sarampo nas Américas, apesar de o Brasil ter conquistado a Certificação Internacional de área livre do sarampo, foi emitida a Nota Técnica nº 63/2025. Esta preconizou a indicação de dose zero da vacina contra sarampo em locais considerados de risco (fronteiras e/ou grande fluxo de imigrantes).

Público-alvo: lactentes entre 6 meses a 11 meses e 29 dias de vida

Locais de aplicação: Roraima, Amapá, Região Metropolitana de Belém, Região Metropolitana de São Paulo, municípios de fronteira e com maior circulação de pessoas da Região Sul do Brasil

Tipos de vacina: dupla viral ou tríplice viral

Devido à baixa resposta imunológica nesta faixa etária, a dose zero é aplicada como medida adicional de proteção em regiões com maior risco de exposição ao vírus, sem substituir as doses do calendário de rotina (12 e 15 meses de vida).

ASPECTO	COMO ERA:	COMO FICOU:
Esquema vacinal sarampo	1ª dose: 12 meses 2ª dose: 15 meses	Dose zero: entre 6m e 11m29d, em contextos de risco (não substitui doses de rotina) 1ª dose: 12 meses 2ª dose: 15 meses

Resumo das mudanças:

VACINA	COMO ERA	COMO FICOU	DATA DA MUDANÇA
HPV	2 doses em adolescentes (meninos 11-14 anos e meninas 9-14 anos)	1 dose para 9-14 anos, dose de resgate até 19 anos	Abril/2024
COVID-19	Campanhas emergenciais, sem rotina fixa	Inclusão no calendário rotineiro com esquemas específicos por idade/grupo	Janeiro/2024
Influenza	Campanhas sazonais	Rotina ampliada para vários grupos	2025
Poliomielite	Reforço com VOP (15 meses e 4	Reforço com VIP (15 meses)	2025

	anos)		
Rotavírus	Faixa etária mais restrita	Faixa etária ampliada 1ª dose até 11m29d 2ª dose até 23m29d	2025
Meningocócica	Reforço com meningocócica-C	Reforço e esquema com meningocócica-ACW Y	2025
Sarampo	1ª dose: 12 meses 2ª dose: 15 meses	Dose zero: entre 6m e 11m29d, em contextos de risco (não substitui doses de rotina) 1ª dose: 12 meses 2ª dose: 15 meses	2025

Bibliografia:

- 1) Ministério da Saúde - Calendário de Vacinação:
<https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/calendario> (acesso em janeiro/2026)
- 2) Ministério da Saúde - informativo do Programa Nacional de Imunizações (PNI) explicando cobertura, vacinas disponíveis e calendário técnico:
<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/pni> (acesso em janeiro/2026)
- 3) Nota Técnica nº 63/2025:
<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-te>

[cnicas/2025/nota-tecnica-no-63-2025-cgici-dpni-svsa-ms.pdf](#) (acesso em janeiro/2026)

